Клинические рекомендации

Потеря слуха, вызванная шумом

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**H83.3** — Шумовые эффекты внутреннего уха **Z57.0** — Неблагоприятное воздействие производственного шума
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.03.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/609_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 6

3.1 Жалобы и анамнез 6

3.2 Физикальное обследование 7

3.3 Лабораторные исследования 7

3.4 Исследование слуха 8

3.5 Лучевая и ультразвуковая диагностика 8

3.6 Иные диагностические исследования 9

3.7 Предварительный и заключительный диагноз 9

4. Лечение 9

4.1 Медикаментозное лечение 10

4.2 Физические (нелекарственные) методы 10

4.3 Слухопротезирование 11

4.4 Иное лечение 11

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12

5.1 Организация медицинской помощи 12

5.2 Реабилитация 12

5.3 Первичная профилактика 13
5.4 Диспансерное наблюдение 13
5.5 Факторы, влияющие на исход 14
6. Источник и актуальность 14
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 14

1. Основные положения

- Профессиональная тугоухость: медленно развивающаяся хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость от производственного шума выше предельно допустимого уровня — **80 дБА**.
- Типичная аудиограмма: двусторонний симметричный «провал» **на 4000 Гц** (реже 3000 Гц) с подъёмом на 8000 Гц, без костно-воздушного разрыва; пороги на разговорных частотах ниже, чем на высоких, **не менее чем на 15 дБ**.
- Предварительный диагноз ставит оториноларинголог на периодическом медосмотре или при обращении; заключительный — только центр профпатологии.
- Лечение помогает только на ранних стадиях — «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха; при II–III степени медикаменты малоэффективны, при III степени и трудностях общения — слуховой аппарат.
- Главное — профилактика: средства индивидуальной защиты органа слуха, «защита временем», медосмотры и группы диспансерного наблюдения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Медленно развивающееся хроническое двустороннее нарушение слуха от производственного шума выше предельно допустимого уровня (**80 дБА**): поражение звуковоспринимающего отдела — нейроэпителия внутреннего уха; клинически — хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость.

Акустическая травма в этих КР не рассматривается: её тоже кодируют H83.3, но оформляют как несчастный случай на производстве.

2.2 Этиология и патогенез

Причина — производственный шум выше гигиенических нормативов. Шум **до 90 дБА** учащает временное смещение порогов слуха после смены: это индикатор риска, а не начало профессиональной патологии; при продолжении воздействия возможен переход в постоянное смещение.

Усугубляют действие шума

1. напряжённость и тяжесть труда;
2. нагревающий микроклимат;
3. заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и иммунной систем.

Единой теории нет. Субстрат — дегенерация наружных и внутренних волосковых клеток кортиева органа, процесс восходящий. Главный механизм гибели клеток — оксидативный стресс: апоптоз наружных волосковых клеток проявляется временным повышением порогов, некроз — постоянным смещением порогов и тугоухостью.

Основное звено патогенеза — сосудистые расстройства: снижение кровенаполнения в вертебробазилярной системе, ангиоспазм, затруднение венозного оттока; лабиринтная артерия — концевая, без коллатералей, рецепторы улитки очень чувствительны к гипоксии.

Шум — дополнительный фактор риска артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, нарушений вегетативной регуляции; эти экстраауральные нарушения обычно предшествуют поражению слуха.

На большинстве производств шум действует вместе с вибрацией, инфразвуком, нервно-эмоциональным и физическим напряжением, нагревающим микроклиматом, токсическими веществами.

2.3 Классификация

Классификация потери слуха, вызванной шумом

Степень	Средний порог по воздуху на 500, 1000, 2000, 4000 Гц, дБ
Признаки воздействия шума на орган слуха	11–25
I степень (I «А», I «Б»)	26–40
II степень	41–55
III степень	56–70
IV степень	71–90

Подгруппы I степени

1. I «А»: нет экстраауральной патологии;
2. I «Б»: гипертоническая болезнь 2 степени и выше, ишемическая болезнь сердца, хроническая ишемия головного мозга 2 степени и выше.

Подгруппы нужны для выбора лечения и чтобы предупредить работника с I «Б» о повышенном риске при продолжении работы в шуме.

«Коррекцию на возраст» не применяют: при потере на высоких частотах **более 45–50 дБ** у пожилых нельзя разграничить шум и старение.

Возрастная инволюция слуха начинается **после 35–37 лет** и к 40–49 годам даёт на речевых частотах **до 10 дБ**. Её учитывают только до стадии признаков воздействия шума (Z57.0); при порогах выше параметров пресбиакузиса степень считают от аудиометрического нуля.

2.4 Клиническая картина

Развивается медленно, обычно **10–14 лет**; первые донозологические изменения на аудиограмме возможны **при стаже 5 лет**.

Жалобы по мере развития

1. сначала экстраауральные: нарушение сна, раздражительность, головная боль;
2. позже — хуже разборчивость речи, особенно в шуме, шум в ушах, снижение слуха.

Отоскопия

1. барабанная перепонка втянута, мутная;
2. инъекция сосудов по рукоятке молоточка;
3. световой конус укорочен.

Чаще — при сочетании шума и вибрации.

Развитие изменений на аудиограмме

1. сначала повышение порогов **на 12, 14, 16 кГц**;
2. затем «провал» **на 4000 Гц** (реже 3000 Гц) с подъёмом на 8000 Гц — на восприятие речи не влияет, выявляется только аудиометрией;
3. при продолжении шума «провал» расширяется на соседние частоты; жалоб на слух ещё нет.

Костно-воздушного разрыва нет.

Отличия от пресбиакузиса

1. пологая нисходящая кривая, наибольшее повышение порога на 4000 Гц;
2. средний порог на 500, 1000, 2000 Гц всегда ниже, чем на 3000, 4000, 6000 Гц, разница **не менее 15 дБ**;
3. пороги на 3000, 4000, 6000 Гц всегда выше, чем на 8000 Гц;
4. шум обычно не даёт потери **более 75 дБ** на высоких и **более 40 дБ** на разговорных частотах.

У работников **старше 50–55 лет** «провал» менее выражен; без прежних аудиограмм начальные признаки трудно отличить от пресбиакузиса. При сочетании шума и возраста вместо «провала» формируется «впадина».

Типичные клинико-аудиологические признаки

1. постепенное повышение порогов по типу нарушения звуковосприятия в течение нескольких лет, **не менее 5**;
2. двусторонний процесс;
3. нет костно-воздушного разрыва;
4. нисходящая кривая с «провалом» на 4000 или 3000 Гц;
5. постепенное повышение порогов на 1000 и 2000 или 3000 Гц;
6. при стаже **20 лет и более** — значительнее на речевых частотах, выраженные «провалы» на 2000 и 4000 Гц.

Самые ранние изменения выявляет вызванная отоакустическая эмиссия. Нет задержанной ОАЭ **более чем в 4 частотных полосах** при нормальных тональных порогах — неблагоприятный признак, показание к динамическому наблюдению и реабилитации.

Для скрининга задержанная ОАЭ предпочтительнее ОАЭ на частоте продукта искажения.

Надпороговые и объективные тесты

1. положительный феномен ускоренного нарастания громкости, дифференциальный порог 0,6–0,4 дБ в начале; 1,5–3 дБ — при нарастании тугоухости;
2. показатели теста Si-Si растут с тугоухостью, до 100% при повышении порога **на 40 дБ**;
3. слуховое поле сужено до 90 дБ, возможен гиперакузис;
4. повышение порогов на 16, 14, 12 кГц в расширенном диапазоне;
5. тимпанограмма тип «А», акустический рефлекс сохранён (60–70 дБ), при высокой степени тугоухости не вызывается;
6. амплитуда задержанной ОАЭ снижена, выпадают частоты (прежде всего 4000 или 3000 Гц); при порогах **более 30 дБ** ОАЭ не регистрируется.

Экстраауральные проявления

1. головная боль, раздражительность, утомляемость, нарушение сна;
2. шум в ушах, головокружение с потемнением в глазах;
3. боль в области сердца, сердцебиение;
4. при осмотре: изменение сухожильно-периостальных рефлексов, тремор пальцев, стойкий дермографизм, акроцианоз, потливость, неустойчивость в позе Ромберга.

Шум вместе с вибрацией раздражает вестибулярный анализатор: «уплывание глаз», диссоциация вестибуло-окулярных реакций при калорической и вращательной пробах. Для «шумовых» профессий характерно понижение вестибулярной возбудимости.

---

3. Диагностика

Два этапа

1. предварительный диагноз — на периодическом медосмотре или при любом обращении;
2. заключительный — только учреждение профпатологии с лицензией по профпатологии, экспертизе связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности.

Критерии диагноза

1. жалобы: постепенное снижение слуха, больше на высоких частотах, низкочастотный шум в обоих ушах или в голове, хуже разборчивость речи в шуме;
2. в анамнезе нет сердечно-сосудистых болезней, церебрального атеросклероза, остеохондроза, нарушений липидного обмена, сифилиса, сахарного диабета, болезней среднего уха и носоглотки, травм головы, наследственной тугоухости, лечения аминогликозидами;
3. стаж в шуме **10 лет и более**, уровень шума **выше 80 дБА**.

При осмотре

1. пальпация уха и сосцевидного отростка безболезненна;
2. слуховой проход свободен;
3. барабанная перепонка чаще матовая, слегка втянута, световой конус укорочен, сосуды по рукоятке молоточка инъецированы.

Кровь в норме, липидный профиль нарушен.

Инструментально: двусторонняя симметричная нисходящая кривая с «провалом» на 4000 Гц, без костно-воздушного разрыва; надпороговые тесты — как в разделе «Клиническая картина». Отсутствие задержанной ОАЭ **на 4000 Гц** — ранний признак воздействия шума.

3.1 Жалобы и анамнез

Уточнить характер работы, шум на рабочем месте и стаж в нём, все прежние профессии и вредные факторы, сопутствующие болезни.

Характерно для шумовой тугоухости

1. нет недавних острых заболеваний, в том числе COVID-19;
2. раздражительность, нарушение сна;
3. шум в обоих ушах или в голове раньше снижения слуха;
4. нет хронических болезней среднего уха, гипертензии, диабета, нарушений липидного обмена;
5. нет шумных увлечений: громкой музыки, стрельбы;
6. нет тугоухости у близких родственников;
7. постепенное снижение слуха;
8. «шумоопасная» профессия, стаж в шуме выше допустимого **более 8–10 лет**.

3.2 Физикальное обследование

Всем работающим в шуме выше допустимого — на медосмотре оториноларинголог: выявить нарушения слуха и противопоказания к работе. При типичных жалобах и аудиограмме и стаже **10 лет и более** он вправе поставить предварительный диагноз профессиональной тугоухости.

Осмотр наружного уха и сосцевидного отростка.

Осмотр верхних дыхательных путей: болезни носа и околоносовых пазух как дополнительная причина снижения слуха.

При подозрении на шумовую тугоухость — повторный осмотр оториноларинголога в учреждении профпатологии: заключительный диагноз, профпригодность, группа диспансерного наблюдения, индивидуальная программа реабилитации слуха.

При углублённом обследовании в стационаре профпатологии — ежедневный осмотр оториноларинголога.

Сурдолог-оториноларинголог: первично — при трудной дифференциальной диагностике; повторно — для заключительного диагноза и программы реабилитации, в том числе слухопротезирования.

Повторный приём сурдолога — углублённое обследование слуха, решение о реабилитации и слухопротезировании.

Терапевт и невролог — на предварительном и периодических медосмотрах: экстраауральные эффекты шума, противопоказания к работе в шуме, лечение сопутствующих болезней; повторно — при заключительном диагнозе.

Повторный приём терапевта — при установлении заключительного диагноза.

Невролог первично — экстраауральные эффекты шума на нервную систему, противопоказания к работе в шуме.

Невролог повторно — при установлении заключительного диагноза.

Профпатолог первично, по результатам медосмотра

1. противопоказания к работе в шуме;
2. возможность предварительного диагноза;
3. запрос санитарно-гигиенической характеристики условий труда;
4. направление в центр профпатологии.

Повторно — заключительный диагноз, профпригодность, диспансерная группа.

Повторный приём профпатолога — в учреждении профпатологии при решении о заключительном диагнозе.

3.3 Лабораторные исследования

Всем работникам «шумоопасных» профессий и пациентам

1. развёрнутый общий анализ крови;
2. общий анализ мочи;
3. биохимический общетерапевтический анализ крови;
4. липидный профиль: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэффициент атерогенности — значимы для патогенеза.

Общий анализ мочи — в рамках общеклинического обследования.

Биохимический общетерапевтический анализ крови — в рамках общеклинического обследования.

Липидный профиль — выявить дополнительные экстраауральные эффекты шума.

3.4 Исследование слуха

Аудиометрию работникам в шуме проводят **не ранее чем через 14 часов** после прекращения контакта с шумом — чтобы исключить временное смещение порогов.

Жалобы на снижение слуха: камертональные пробы Вебера и Ринне — ориентировочная оценка, разграничение нарушения звукопроведения и звуковосприятия.

Всем работникам «шумоопасных» профессий — тональная пороговая аудиометрия с воздушным и костным проведением: основной метод диагностики и дифференциальной диагностики, выявляет ранние сдвиги порогов.

Аудиометрия в расширенном диапазоне — самые ранние изменения **на 12, 14, 16 кГц**, не видимые другими методами.

Надпороговые тесты (проба Люшера, порог дискомфорта, тест Si-Si) — углублённая оценка и уточнение уровня поражения.

Речевая аудиометрия — по показаниям, для профпригодности по отраслевым требованиям, прежде всего в гражданской авиации.

Импедансометрия — дифференциальная диагностика и уровень поражения слухового анализатора; при экспертизе связи с профессией обязательна.

Вызванная отоакустическая эмиссия — самые ранние нарушения, подтверждение степени, исключение аггравации и симуляции. Изменения прежде всего в полосе 4 кГц.

Отсутствие ОАЭ **более чем в 4 частотных полосах** — показание к расширенному аудиологическому обследованию; подавление ОАЭ **на 4 кГц** при нормальных тональных порогах — неблагоприятный признак, показание к динамическому наблюдению.

Задержанная ОАЭ предпочтительна для скрининга работающих в шуме.

ОАЭ на частоте продукта искажения — степень повышения порогов, уточнение аудиограммы при экспертизе.

Сложные и спорные случаи: коротколатентные слуховые вызванные потенциалы — основной метод объективного определения порогов; исключение аггравации и симуляции.

Там же — ASSR-тест (вызванные ответы мозга на постоянные модулированные тоны) для объективизации порогов.

Вестибулярная функция — при жалобах на головокружение и шаткость; на медосмотре — оценка спонтанного нистагма, при возможности вестибулометрия.

3.5 Лучевая и ультразвуковая диагностика

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий — кровоснабжение внутреннего уха.

Рентгенография шейного отдела позвоночника — причины нарушения кровообращения в вертебробазилярной области.

Рентгенография околоносовых пазух — состояние пазух и слуховой трубы как сопутствующие причины.

КТ височных костей — дифференциальная и топическая диагностика, по согласованию с рентгенологом, с контрастом или без; односторонние нарушения могут скрывать двусторонний процесс (например, нейрофиброматоз II типа).

МРТ, в том числе с контрастом, — внутренние слуховые проходы, мостомозжечковые углы, задняя черепная ямка.

Лечить шум в ушах и тугоухость без дифференциальной диагностики нельзя: например, при невриноме слухового нерва витамины, ноотропы и физиотерапия могут ускорить рост опухоли.

3.6 Иные диагностические исследования

Рефлексотерапевт и физиотерапевт — определить показания и противопоказания к своим методам лечения.

Физиотерапевт — показания и противопоказания к физиотерапии.

3.7 Предварительный и заключительный диагноз

Подозрение на профессиональную тугоухость
Двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость с типичной аудиограммой при условии:

1. шум на рабочем месте **до 90 дБА** — стаж **15 лет и более**;
2. шум **более 90 дБА** — стаж **10 лет и более**.

Признаки воздействия шума (Z57.0) на медосмотре — ограничений профпригодности нет; работник в группе повышенного риска, ему разрабатывают индивидуальную программу реабилитации слуха. Это донозологическое состояние, а не заболевание.

После предварительного диагноза работника **в течение 30 дней** направляют в центр профпатологии; подаётся извещение в Роспотребнадзор.

Связь с профессией после прекращения работы в шуме рассматривают, только если тугоухость документально подтверждена в период работы; появление или прогрессирование тугоухости после прекращения контакта с шумом основанием не является. Перерывы в стаже снижают вероятность прогрессирования.

Формулировки заключительного диагноза

1. признаки воздействия шума (Z57.0) — трудоспособен без ограничений;
2. I «А» степень — трудоспособен в профессии при наблюдении в центре профпатологии раз в год, разработана программа реабилитации слуха;
3. I «Б» степень — трудоспособен при наблюдении 2 раза в год, предупреждён о риске;
4. II степень и выше — работа в шуме выше 80 дБА противопоказана, направление на медико-социальную экспертизу.

---

4. Лечение

Лечение эффективно только в самых начальных стадиях — «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха, и только при устранении шума. Лечение такое же, как при нейросенсорной тугоухости непрофессионального генеза: микроциркуляция внутреннего уха, мозговая гемодинамика, оксигенация.

Курсы **не менее 10 дней**, **не реже 2 раз в год**; в группе риска — раз в год.

Работникам «шумоопасных» профессий — охранительный слуховой режим.

4.1 Медикаментозное лечение

Шум в ушах и сенсоневральная тугоухость: «Признаки воздействия шума на орган слуха» (Z57.0) и I степень потери слуха

1. ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции;
2. периферические вазодилататоры;
3. ноотропные препараты;
4. препараты для устранения головокружения;
5. психоаналептики.

Применение вне инструкции при H83.3 допускается распоряжением Правительства № 1180-р. При II и III степени медикаментозное лечение малоэффективно.

Шум в ушах, Z57.0 или I степень — витамины группы B, дозы по инструкции.

Поддерживающие курсы — по индивидуальным показаниям с учётом соматических болезней, вместе с профильными специалистами.

4.2 Физические (нелекарственные) методы

Немедикаментозные методы значительно повышают эффективность лекарств. Все — при отсутствии противопоказаний, при шуме в ушах и потере слуха от шума.

Метод	Показания
рефлексотерапия	Z57.0 и I степень
электропунктура	Z57.0 и I степень
лазеропунктура	Z57.0 и I степень
транскраниальная электростимуляция	любая степень
магнитотерапия на шейный отдел позвоночника и сосцевидные отростки	I–II степень
УВЧ на шейный отдел позвоночника и сосцевидные отростки (УДД 4)	любая степень
дарсонвализация органа слуха	любая степень
эндауральная дарсонвализация (УДД 4)	любая степень
внутриушной электрофорез лекарственных препаратов	любая степень
плазмаферез	любая степень
лекарственный ультрафонофорез	любая степень

Метод	Показания
электрофорез синусоидальными модулированными токами (УДД 4)	шум в ушах и потеря слуха
общий медицинский массаж	любая степень
медицинский массаж шеи	любая степень
массаж воротниковой области	любая степень
гипербарическая оксигенация	начальные нарушения, усиление базисной терапии
заушные блокады с лекарственными препаратами	Z57.0 и I степень, шум в ушах и в голове

4.3 Слухопротезирование

Необратимая III степень и трудности общения — подбор слухового аппарата: цифровые аппараты, бинаурально или моноурально, вместе с лечебно-реабилитационными мероприятиями.

Хирургическое лечение при сенсоневральной тугоухости, в том числе шумовой, не показано.

4.4 Иное лечение

Лечебно-оздоровительный режим — уменьшить стресс и экстраауральные эффекты шума.

Диетическое питание индивидуально, с учётом нарушений липидного обмена; без иных показаний — стол № 10 или 15.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Организация медицинской помощи

Порядок

1. предварительный диагноз ставит оториноларинголог или сурдолог любой медицинской организации амбулаторно;
2. **в течение суток** — направление к профпатологу по месту жительства;
3. профпатолог подтверждает диагноз и **в 3-дневный срок** направляет извещение в Роспотребнадзор.

1. Роспотребнадзор **в 2-недельный срок** составляет санитарно-гигиеническую характеристику условий труда;
2. профпатолог **в месячный срок** направляет пациента в учреждение профпатологии.

С собой

1. копия трудовой книжки;
2. выписки предварительного и периодических медосмотров;
3. результаты обследований;
4. копии аудиограмм за весь период работы в шуме;
5. санитарно-гигиеническая характеристика — всё заверено печатями.

Заключительный диагноз устанавливает врачебная комиссия учреждения профпатологии — амбулаторно или после обследования в стационаре; извещение **в 3-дневный срок** направляют в Роспотребнадзор, работодателю, страховщику и в направившую организацию.

При предварительном диагнозе показаний к госпитализации нет. Госпитализация в учреждение профпатологии — для углублённого обследования перед заключительным диагнозом.

Выписка — после решения об установлении или отсутствии заключительного диагноза.

5.2 Реабилитация

Всем работникам «шумоопасных» профессий — краткое профилактическое консультирование: причины и профилактика, средства индивидуальной защиты органа слуха, здоровый образ жизни.

Медицинская реабилитация при любой степени — разработка индивидуальной программы реабилитации слуха.

Санаторно-курортное лечение — всем работающим в шуме, в том числе без нарушений слуха: в отпуск, **не реже раза в год**, в санатории, дневном стационаре, профилактории, доме отдыха.

Объём определяют

1. терапевт, невролог, хирург;
2. медицинский психолог или психиатр;
3. офтальмолог, оториноларинголог.

Программы оздоровления составляют с учётом шума и сопутствующих факторов, класса условий труда, здоровья работника, формы и степени тугоухости.

Результат реабилитации: устранение или значительное улучшение слуха, положительная динамика аудиометрии, лучшее самочувствие.

Эффективность оздоровления оценивают по медико-социальным и экономическим показателям: заболеваемость с временной нетрудоспособностью, новые случаи профессиональной тугоухости, число профнепригодных и инвалидов.

Лечебный массаж шеи и воротниковой области — ежедневно, курс **до 10 процедур**.

Слуховой тренинг в шлеме виртуальной реальности — дополнительно при лёгкой сенсоневральной тугоухости и скрытой потере слуха: ежедневно **7 дней**, занятие **15 минут** с паузой 2 минуты.

Вестибулярные тренировки, в том числе с виртуальной реальностью: ежедневно или через день **по 30 минут**, курс **20 процедур**.

5.3 Первичная профилактика

Технические меры

1. специальная оценка условий труда;
2. снижение шума и усиливающих его факторов (вибрации, напряжения, вынужденной позы) до нормативов;
3. замена шумных технологий;
4. коллективная защита: шумозащитные панели, перегородки, потолки.

Средства индивидуальной защиты органа слуха

1. противошумные наушники;
2. вкладыши («беруши»);
3. шлемы и костюмы.

Применяют, если коллективная защита не снижает шум до нормы; работодатель предоставляет их бесплатно.

«Защита временем»

1. 10-минутные регламентированные перерывы с подменой: при высокой нагрузке — **каждые 2 часа**, при средней — **не реже чем каждые 4 часа**;
2. работа с шумом или вибрацией **не более 2/3 смены**;
3. микропаузы в шумных операциях, смена «шумоопасной» профессии на «шумобезопасную» в комплексной бригаде.

Для обоснования мер первичной профилактики — расчёт группового избыточного риска потери слуха от шума (приложение Г1 КР).

Вспомогательно: производственная гимнастика, ультрафиолетовое облучение, витамины, сбалансированное питание; отдых в комнатах психологической разгрузки.

Отдых в комнатах психологической разгрузки, домах отдыха — снятие хронического стресса от шума.

Медицинский отбор в профессию — на предварительном и периодических медосмотрах по приказу Минздрава № 29н.

5.4 Диспансерное наблюдение

Периодические медосмотры — диспансеризация трудовых коллективов; по их результатам выделяют группы динамического наблюдения.

Группы наблюдения формируют по результатам медосмотров.

Группы динамического наблюдения

Группа	Кто входит	Наблюдение
I «А»	практически здоровые: шум **не выше 90 дБА** при любом стаже или **выше 90 дБА** при стаже **до 10 лет**	медосмотр раз в год, профилактика, подбор и использование средств защиты
I «Б»	практически здоровые: шум **выше 90 дБА**, стаж **более 10 лет**	как I «А» + массаж воротниковой зоны 2 раза в год, рефлексотерапия раз в год

Группа	Кто входит	Наблюдение
II	признаки воздействия шума на орган слуха (Z57.0)	как I «Б» + гипербарическая оксигенация, лекарства, санаторно-курортное лечение раз в год
III «А»	потеря слуха от шума I «А» степени	трудоспособен; центр профпатологии раз в год, программа реабилитации, лекарства и немедикаментозное лечение, санаторий раз в год
III «Б»	I «Б» степень: в сочетании с гипертонической болезнью или хронической ишемией мозга 2 степени и выше	как III «А» + лечение сосудистой патологии; курс и центр профпатологии 2 раза в год
III «В»	II степень и выше (H83.3, H90.3) любой этиологии	непригоден к работе в шуме, медико-социальная экспертиза; наблюдение по месту жительства 2 раза в год

При хронической сенсоневральной тугоухости любой степени — индивидуальная программа реабилитации слуха; разрабатывает и контролирует оториноларинголог или сурдолог-оториноларинголог.

5.5 Факторы, влияющие на исход

Сердечно-сосудистые болезни и нарушения липидного обмена усиливают действие шума: тугоухость развивается быстрее, пороги на высоких частотах выше, типичные аудиологические признаки стираются. Шум может вызвать соматизированное депрессивное расстройство.

Усиливают вред шума

1. стрельба, охота, громкая музыка, особенно в наушниках;
2. алкоголь, курение, наркотики;
3. лечение аминогликозидами в анамнезе;
4. глухота у близких родственников;
5. травмы головы.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Потеря слуха, вызванная шумом»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 15.03.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее марта 2027 года
Код в рубрикаторе	`609_2` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Национальная медицинская ассоциация сурдологов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Липиды противоречат друг другу: в разделе 1.2 при действии шума снижены ЛПВП, в критериях диагноза (раздел 2) — «повышены» общий холестерин, ЛПВП и ЛПНП.

- Стаж для подозрения на профессиональную тугоухость указан по-разному: «10 и более лет» (раздел 2), «более 8–10 лет» (раздел 2.1), 15 лет при шуме до 90 дБА и 10 лет при шуме выше 90 дБА (приложение Б).
- Для группы III «А» немедикаментозное лечение отсылает к разделу 3.2, но там хирургическое лечение (не рекомендуется); немедикаментозные методы — раздел 3.1.2.
- PDF в рубрикаторе — распознанный скан: в цитатах журнала сверки встречаются ошибки распознавания (например, «257.0» вместо Z57.0, «81-81» вместо Si-Si). Цифры таблиц сверены по изображениям страниц.